帶領者專用 • 請勿發給學員

跨科系協作信任賽局｜〈加護病房床位的每月抉擇〉

一個關於「共好、信任與長期合作」的重複賽局體驗

這個活動在教什麼

- 合作的共同利益，遠大於背叛的短期利得——而且越早、越穩地達成互信共好，八個月累計創造的價值越大。
- 信任沒有捷徑：在不能明講的回合裡，你的每一次選擇，就是你送出的訊號。
- 一次背叛，可能讓雙方長期陷入「誰也不敢先讓床」的低量能僵局；修復信任的成本，遠高於維持信任。
- **適合作為跨部門稀缺資源協作、利害關係人溝通協調的體驗式暖身，也能獨立用於跨科系／跨專業協作與信任主題。**

賽局結構（帶領者才知道的策略分析）

下方為標註版收益矩陣。每格右上為**外科隊**的量能、左下為**內科隊**的量能，單位為「重症收治量能點數」。

內科隊↓ ／ 外科隊→	外：全力共援	外：保留一手	外：優先自保
內：全力共援	外：11 內：11	外：18 內：2	外：15 內：2
內：保留一手	外：2 內：18	外：8 內：8	外：15 內：3
內：優先自保	外：2 內：15	外：3 內：15	外：5 內：5

- **共好點（綠）：** 雙方都「全力共援」→ 各得 11／回合，這是帕累托最佳，也是要引導他們盡快抵達並守住的位置。
- **納許陷阱（紅）：** 雙方都「優先自保」→ 各得 5／回合，穩定但雙輸；信任一崩，雙方最佳反應就收斂到這裡。
- **背叛誘惑：** 對方全力共援、你卻保留一手（私下預留床位）→ 你 18、對方僅 2。這是最甜的陷阱，也最會招來報復。
- **崩壞路徑：** 被背叛的一方，最佳反應是退到「優先自保」；於是雙方一路滑到 5／5，剩餘回合全毀。

用數字打臉「背叛比較划算」（debrief 王牌）

全程守住共好（含加權回合）約可累計 121 點；雙方互相自保只有 55 點。若某方在第 4 回合背叛一次（該回合搶到 36 點），招致報復、後段崩到自保，該背叛者總帳約 99 點——仍低於一路共好的 121。也就是說，**背叛連背叛者自己都划不來。**

帶領者專用（續）

流程與時間（建議 30–40 分鐘）

1. **分隊配對（3 分）：** 四組兩兩配對，共 2 場對局；每場一組擔任內科隊、一組擔任外科隊。發共同說明與各自的記錄表。
2. **讀規則（4 分）：** 各隊讀懂三種投入等級與收益矩陣、加權回合與溝通規則。
3. **八回合對局（18–22 分）：** 每回合雙方「同時亮牌」（一起翻出寫著等級的卡／手勢），對照矩陣各自記分。
4. **揭盅與 Debrief（8–10 分）：** 公布各隊累計、對照『全程共好』的理論上限，帶回跨部門稀缺資源協作的討論。

回合與溝通規則（帶領者控場）

- **同時亮牌：** 每回合雙方同時出示本隊等級，不得看到對方後才改。
- **沉默回合：** 第 1–3 回合不得交談（兩系關係緊張、醫療部未授權私下協調），只能用選擇傳遞善意。
- **會談窗口：** 第 4、第 7 回合開始前，各開放 2 分鐘雙邊代表會談，可承諾但不具約束力。
- **加權回合：** 第 4 回合 ×2、第 8 回合 ×3（拉高「臨門背叛」的誘惑，凸顯信任在關鍵時刻的脆弱與價值）。

現場常見動態與帶領提醒

- 多數配對會在被背叛一次後崩到自保——引導他們算出『崩壞後段的損失』與『修復信任要花幾回合』。
- 若有配對很快穩定共好，請他們分享：第一個善意是誰先給的？對方如何回應？（→ 主動釋出＋可靠回報）
- 會談窗口的口頭承諾若被背叛，情緒會很真實——這正是談『沒有制度保障的信任有多脆弱』的好素材，也最貼近臨床上「說好要讓床、最後沒讓」的經驗。

Debrief 四問（接回跨部門稀缺資源協作）

1. 你們花了幾回合才穩定共好？中間是什麼建立或摧毀了信任？
2. 有沒有人保留一手？私下預留床位換來的短期量能，抵得過後面崩壞的損失嗎？（出示總帳）
3. 沒開放溝通的回合，你們靠什麼判斷對方的意圖？——對照現實：平常各科系是憑什麼判斷對方「會不會讓床」？
4. 放大到全院的稀缺資源協作（加護病房床位、手術室時段、隔離病房等）：為什麼「共好」需要被制度化，而不能只靠善意？床位調度制度、透明的即時床位資訊、跨系績效共享，各自能補上哪一塊信任缺口？

學員共同說明 ・ 內科隊、外科隊皆讀（規則相同）

〈加護病房床位的每月抉擇〉賽局規則

你和另一隊，分別是同一家醫學中心裡內科系與外科系的主管團隊——以下簡稱內科隊與外科隊。兩系共用一批數量有限的加護病房床位，急診、病房與術後病人的轉入、轉出，都得在這批床位裡調度。接下來的八個月，每個月月初，兩隊要各自、同時決定本系這個月的「協作投入等級」。你的目標很單純：讓你自己這一系八個月累計的「重症收治量能點數」愈高愈好。你不需要為對方的收治量能負責。

為了避免臨時喬床、影響公平，醫療部規定兩隊必須在每月月初同時決定、同時亮牌。你可以選擇的投入等級有三種：

- **全力共援：**依病情嚴重度共同調度床位，主動讓出可轉出的床位，也接受對方的病人轉入。
- **保留一手：**表面配合共同調度，私下替自家病人預留床位。若對方全力共援、你卻保留一手，你等於用到對方讓出的床位、又守住自己的，短期你的收治量能會衝很高——但對方會被擠到無床可用。
- **優先自保：**床位只給自家病人，不參與共同調度。當雙方都自保，轉床卡關、急診滯留、手術排程延宕，兩隊收治量能都低。

關鍵在於：你這個月的收治量能，不是只由你決定，而是同時取決於你和對方這個月各自的選擇。下面這張表，就是各種組合下、雙方各自會拿到的量能點數。每一格的右上角、以「外」開頭的，是外科隊的量能；左下角、以「內」開頭的，是內科隊的量能。單位都是「重症收治量能點數」。

內科隊↓ ／ 外科隊→	外：全力共援	外：保留一手	外：優先自保
內：全力共援	外：11 內：11	外：18 內：2	外：15 內：2
內：保留一手	外：2 內：18	外：8 內：8	外：15 內：3
內：優先自保	外：2 內：15	外：3 內：15	外：5 內：5

溝通與計分規則

- 兩系過去因床位分配、轉床爭議與績效歸屬有過摩擦，關係略為緊張；醫療部並未授權你們私下協調，所以原則上不能公開串通。
- 第 1 至 3 回合不得交談，只能用你的選擇傳遞意圖；第 4、第 7 回合開始前，各有 2 分鐘雙邊會談（可以承諾，但沒人保證對方會遵守）。

- 加權回合：第 4 回合的量能 ×2、第 8 回合 ×3。請把每回合結果與加權，逐月記在你的記錄表上。

每月抉擇記錄表 • 每隊各持一份

重症收治量能記錄表｜逐月填寫

本隊： ☐ 內科隊　☐ 外科隊　　**隊員：** _____

回合	我方投入等級	對方投入等級	我方本回合量能（點）	加權係數	我方累計量能（點）
1				× 1	
2				× 1	
3				× 1	
4				**× 2**	
5				× 1	
6				× 1	
7				× 1	
8				**× 3**	

八個月累計量能總分： _____ 點

對照參考（帶領者揭盅後填）：

- 全程共好的理論上限：約 121 點　｜　雙方互相自保：約 55 點。
- 我們距離『全程共好』差了多少？差距發生在哪幾個回合？